

Wstyd w AvPD

Wstyd = **rdzeń AvPD** (Millon 2011) — nie lęk, wstyd bycia sobą. CFT Gilberta: współczucie aktywuje układ uspokojenia, neutralizujący wstyd. Przepisywanie obrazów (ang. *imagery rescripting*) + ekspozycja.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: Millon (2011); Kaufman (1989); Gilbert (2009, 2010); Matos i wsp. (2013)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz różnicę między lękiem a wstydem (sekcja 01). **2** · Poznasz mechanizm **CFT Gilberta** — układ zagrożenia vs układ uspokojenia (sekcja 02). **3** · Sprawdzisz swój wzorzec wstydu (sekcja 03). **4** · Poznasz **czterostopniową sekwencję pracy** ze wstydem (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wstyd jest **rdzeniem AvPD** (Millon 2011): nie „lęk społeczny”, ale *zinternalizowany wstyd bycia sobą* — przekonanie „*jeśli mnie zobaczą naprawdę, odkryją że jestem wadliwy/-a*”. Kaufman (1989): wstyd, który stał się *tożsamością*. Gilbert (2010, CFT): samowspółczucie aktywuje układ uspokojenia, neutralizujący wstydy układ zagrożenia. Różnica od SAD: lęk mówi „*co pomyślą*” (o sytuacji); wstyd mówi „*jestem nie tak*” (o mnie). Sytuacyjne narzędzia (oddech, ekspozycja) działają na lęk i są **nieskuteczne wobec wstydu** — bo nie ma „sytuacji”, do której wstyd się odnosi. Pacjent leczony jak SAD odbija się od ściany. Wstyd wymaga innej sekwencji: normalizacja, przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*), CFT (budowanie współczującego głosu), ekspozycja na wstyd (celowe „bycie niedoskonałym” publicznie). Matos i wsp. (2013): trening współczucia redukuje wstyd *niezależnie* od redukcji lęku.

01 📋 Lęk vs wstyd — fundamentalna różnica

LĘK — O SYTUACJI

„*Co pomyślą*”. Lęk dotyczy **tego, co zewnętrzne**. Ma „sytuację”, do której się odnosi. Działają oddech, ekspozycja, restrukturyzacja myśli. SAD = lęk performansowy.

WSTYD — O MNIE

„*Jestem nie tak*”. Wstyd dotyczy **tego, kim jestem**. Nie ma sytuacji odniesienia. Działa w samotności. Lękowe narzędzia odbijają się od niego. AvPD = wstyd tożsamościowy.

Klucz kliniczny: pacjent leczony jak SAD — z hierarchią ekspozycji i restrukturyzacją myśli — kończy 16 sesji z *mniej*szym lękiem sytuacyjnym, ale wciąż mówi: „*nał jestem wadliwy/-a*”. Wstyd *nie ma* sytuacji do ekspozycji — i wymaga innej sekwencji terapeutycznej.

02 CFT Gilberta — trzy układy regulacji

UKŁAD ZAGROŻENIA

amygdala, kortyzol
wstyd, lęk, gniew
dominuje w AvPD

UKŁAD POBUDZENIA

dopamina, energia
osiąganie celów
aktywny, produktywny

UKŁAD USPOKOJENIA

oksytocyna, układ
przywspółczulny

cel CFT trening współczucia przesuwą równowagę w stronę uspokojenia

Mechanizm: wstyd aktywuje układ zagrożenia (ciało migdałowe, kortyzol). Współczucie aktywuje układ uspokojenia (oksytocyna, układ przywspółczulny). Te dwa układy *konkurują* — trening współczucia **stopniowo** przesuwą równowagę. To zmiana *fizjologiczna*, nie tylko poznawcza. Matos 2013: redukcja wstydu mierzalna niezależnie od redukcji lęku.

03 Mój wzorzec wstydu

KIEDY OSTATNIO CZUŁEM/-AM WSTYD?

— konkretna sytuacja, co dokładnie poczułem/-am?

CO WSTYD MÓWIŁ O MNIE?

— „jestem...” — zdanie tożsamościowe

NAJWCZEŚNIEJSZE WSPOMNIENIE WSTYDU

— wiek, sytuacja, kto był obecny?

CO BYM POWIEDZIAŁ/-A DZIECKU W TEJ SCENIE?

— jak ciepło, jak ochronnie?

04 Czterostopniowa sekwencja pracy ze wstydem

1 • NORMALIZACJA

„Wstyd jest **ludzki**, każdy go ma”. Brown: *vulnerability is courage*. Najpierw rozdzielenie: wstyd jako emocja ≠ tożsamość.

2 • PRZEPISYWANIE OBRAZÓW

Wczesna scena wstydu — Dorosły wchodzi, broni Dziecka, mówi to, czego Dziecko nie usłyszało. Praca z pamięcią emocjonalną.

3 • CFT — WSPÓŁCZUJĄCY GŁOS

Budowanie *współczującego głosu* zamiast krytycznego. *Compassionate self*: ciepły ton, walidacja, ochrona. Codzienna praktyka.

4 • EKSPOZYCJA NA WSTYD

Celowe „bycie niedoskonałym” publicznie (*shame attack*). Cel: **doświadczyć**, że wstyd minie, nie zniszczy.

Klucz: wstyd w AvPD *nie* jest objawem — jest **rdzeniem** (Millon 2011). Lękowe narzędzia (oddech, ekspozycja) działają na sytuację, *nie* na tożsamość. CFT Gilberta: trening współczucia **fizjologicznie** przesuwą równowagę z układu zagrożenia do uspokojenia. Matos 2013: redukcja wstydu mierzalna niezależnie od redukcji lęku. Praca ze wstydem wymaga **długiej stabilnej relacji terapeutycznej** — wstyd nie ujawni się w pierwszych miesiącach. Sygnał gotowości: pacjent zaczyna mówić o sobie w pierwszej osobie z bólem („nienawidzę siebie”), nie tylko opisuje sytuację. Wcześniej praca ze wstydem jest *przedwczesna*.